EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 75390
SERVICIO : CIRUGIA HSC
FECHA : 2023-12-06 11:22:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: IVAN MAURICIO STAHL RODRIGUEZ			RUN	: 9.382.240-4
F.Nac	: 03-08-2021	Edad	: 2 AÑOS, 4 MESES	Género	: Masculino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-11-21	Fecha Egreso	: 2023-12-06 11:22:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. R10.1-DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

DIVERTICULITIS AGUDA
SHOCK SEPTICO ABDOMINAL
POP LAPAROTOMIA POR MULTIPLES ABSCESOS PERIETOCOLICOS E INTERASS
AKI KDIGO I PRERENAL RESUELTA
HEMICOLECTOMIA IZQUIERDA + SIGMOIDECTOMIA CON ANASTOMOSIS PRIMARIA COLO-RECTAL (JUNIO 2023)
DIVERTICULITIS SIGMOIDEA COMPLICADA + COLOSTOMIA HARTMAN 2021
HTA
RESISTENCIA A LA INSULINA
TRASTORNO ANSIOSO DEPRESIVO
FRACTURA POR COMPRESION DE L2

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. R10.1-DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

PACIENTE CON COMORBILIDADES DE HTA, RESISTENCIA A LA INSULINA, SD. DEPRESIVO Y COLITIS ULCEROSA? QUIEN PRESENTO ENFERMEDAD DIVERTICULAR COMLICADA QUE AMERITO COLECTOMIA IZQUIERDA Y COLOSTOMIA CON RESTITUCION DE TRANSITO HACE 4 MESES . EN ESTA OCASION INGRESO EL DIA 19/11/23 POR CUADRO DE DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN HEMIABDOMEN SUPERIOR
SE TOMO TAC DE ABDOMEN Y PELVIS C/C CON DIVERTICULITIS AGUDA
SE HOSPITALIZO E INGRESO A PABELLON DONDE SE REALIZO SE DRENAN ABSCESOS EN GOTERA PARIETOCOLICA E INTERASAS, NO SE LOGRO EVIDENCIAS PERFORACION DE INTESTINO, SE DEJO INSTALADO DRENAJE TUBULAR
PACIENTE EGRESO DE PABELLON A UCI
INGRESA NUEVAMENTE A PABELLON PARA ASEO QUIRURGICO, SE TOMAN CULTIVOS, Y SE DEJA BOLSA DE BOGOTA CON LAPAROTOMIA CONTENIDA.
ULTIMO INGRESO A PABELLON EL DIA 27/11/23 PARA ASEO QUIRURGICO Y CIERRE DE LAPAROTOMIA
DURANTE LA HOSPITALIZACION EN UCI REQUIRIO VMI, Y USO DE DVA, PACIENTE SE EXTUBO Y YA ESTA SIN REQUERIMIENTOS DE O2
INICIALMENTE CON CEFTRIAXONA + METRONIDAZOL, POSTERIORMENTE SE AJUSTO TERAPIA CON RESULTADO DE CULTIVOS
PACIENTE POR BUENA EVOLUCION CLINICA SE DECIDIÓ TRASLADO DE UCI A PISO DE CIRUGIA
PACIENTE EN UNIDAD EN BEG, TRANQUILO
HEMODINAMIA ESTABLE, SIN APREMIO VENTILATORIO
TOLERANDO REGIMEN, DIURESIS +
DEPOSICIONES + POR ANO.

EX FISICO:

ALERTA, VIGIL, OTE
PIEL ROSADA, MUCOSAS HIDRATADAS, LLENE CAPILAR <2S
CARDIOPULMONAR: RR2T NAS. MP+ SRA
ABDOMEN: RHA+ ABDOMEN BDI, SIN SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL, APOSITOS LIMPIOS Y SECOS

PLAN DE MANEJO:

CURACIONES POR HODOM C/48H
COMPLETAR TRATAMIENTO ANTIBIOTICO POR HODOM; ERTAPENEM 11/14; VANCOMICINA 3/5
CONTROL EN CAE DE CIRUAGIA EN 15 DIAS CON DR. ZUGBE
CONTROL EN CAE DE GASTROENTEROLOGIA
CONSULTAR EN URGENCIA SOS

INDICACIONES AL ALTA

1. REPOSO RELATIVO, LEVANTAR FAJADO
2. REGIMEN LIVIANO HIPOSODICO, HIPOGRASO
3. CURACIONES C/48 HRS POR HODOM
4. ARACETAMOL COMPRIMIDO 500 MILÍGRAMOS 2 comprimido cada 8 hrs. por 5 dias via ORAL
5. OMEPRAZOL COMPRIMIDO 20 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
6. ERTAPENEM 1 GR. AMPOLLA UNIDAD 1 ampolla cada 24 hrs. por 3 dias via ENDOVENOSA
7. VANCOMICINA AMPOLLA 500 MILÍGRAMOS 3 ampolla cada 12 hrs. por 2 dias via ENDOVENOSA
8. QUETIAPINA COMPRIMIDO 25 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 15 dias via ORAL
9. GEMFIBROZILO COMPRIMIDO 600 MILÍGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. por 30 dias via ORAL
10. FUROSEMIDA AMPOLLA 20 MILIGRAMOS / MINILITROS 1 ampolla cada 12 hrs. por 30 dias via ENDOVENOSA
11. LOSARTAN POTASICO COMPRIMIDO 50 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. por 30 dias via ORAL
12. METOCLOPRAMIDA AMPOLLA 10 MILIGRAMOS / 2 MINILITROS 1 ampolla cada 8 hrs. por 5 dias via ENDOVENOSA
13. COMPLETAR TRATAMIENTO ANTIBIOTICO POR HODOM
14. CONTROL EN CAE DE CIRUGIA EN 15 DIAS CON DR . ZUGBE
15. CONTROL EN CAE DE GASTROENTEROLOGIA
16. CONSULTAR EN URGENCIA SOS

NICOLÁS JAIME LETELIER ALARCÓN
MEDICO TRATANTE
17757150-4

JEFE SERVICIO